Quest 7 — Hipóteses de precificação para discussão da equipe

Data: 13 de outubro de 2026

Status: rascunho interno para análise da equipe; ainda não é preço validado.

Em vermelho: comentários do Matheus, posicionados junto à seção a que se referem.

Objetivo deste documento

Organizar as possibilidades de cobrança discutidas até agora para que a equipe possa revisar, corrigir e decidir o que investigar primeiro. Não há valores definidos nem evidência de disposição a pagar: a equipe confirmou que ainda não conversou com pessoas idosas, familiares, operadoras ou clínicas sobre esses modelos.

O professor autorizou a equipe a seguir com essa direção e demonstrou avaliação positiva, segundo o relato da equipe. Isso permite continuar a investigação, mas não valida por si só os preços ou os compradores.

Serviço em discussão

A plataforma conectaria pessoas idosas a profissionais cadastrados. As ofertas em foco são:

1. **Acompanhamento presencial:** busca em casa, acompanhamento à consulta e retorno para casa.
2. **Teleconsulta assistida:** apoio presencial com tablet durante a teleconsulta; a aferição mencionada pela equipe ainda precisa ser definida.

O lembrete ativo pode apoiar o fluxo. O resumo pós-consulta também está previsto na ideia, mas ainda falta definir seu conteúdo, destinatário e se estará incluído no serviço.

Os dois tipos de atendimento podem ter tempos, custos e perfis profissionais diferentes. A equipe ainda precisa decidir se vai usar uma tabela comum ou precificação separada.

Comentário do Matheus

Primeiramente, acho válido a gente discutir se de fato vale a pena adicionar Teleconsulta assistida no MVP ou focar 100% em entender o processo do acompanhamento em si, precificação, processo de adquirir profissionais e de como passar confiabilidade. Eu sei que a Teleconsulta assistida é muito válida e importante, mas a minha hipótese é que, na prática, vamos dividir o tempo e quando o produto for para o mercado, não vamos conseguir resolver os problemas que encontrarmos das duas soluções e uma delas acabará sendo abandonada. **Eu focaria em Acompanhamento presencial para o MVP.**

Modelos de cobrança propostos

Canal	Pagador pretendido	Forma de cobrança em discussão	Estado atual
B2B	Operadora ou plano de saúde	PMPM por pessoa idosa elegível	A unidade foi definida como pessoa elegível; os critérios de elegibilidade e a contagem mensal ainda estão em aberto.
B2B	Operadora ou plano de saúde	Pacote mensal de horas ou acompanhamentos	Quantidade, validade e regra para exceder o pacote ainda precisam ser definidos.
B2B	Operadora, plano, clínica, hospital ou laboratório	Taxa por consulta efetivamente acompanhada	A equipe ainda precisa definir o que conta como atendimento faturável e como tratar cancelamentos.
B2C	Pessoa idosa ou familiar	Pagamento por atendimento pontual	Hipótese ainda sem validação com usuários ou pagadores.
B2C	Pessoa idosa ou familiar	Pacote mensal com um número definido de acompanhamentos	A frequência de uso e a aceitação de uma cobrança recorrente ainda precisam ser investigadas.

Comentário do Matheus

B2B: Sobre vender para um plano de saúde ou operadora: eu acho super válido, mas também não para um MVP, é bastante burocrático e é um público tradicionalmente fechado à inovação. Para isso, a melhor forma seria um edital com o Hospital das Clínicas da UFPE por exemplo, mas acho que dá para começar validando o produto sem esse intermediador, assim, a gente encurta o caminho, refina a solução e chegamos em seguida com um produto validado e com cases para os planos e operadores. Resumindo, vender B2B é bom para ganhar dinheiro e escalar, mas no início o foco não é maximizar receita nem escalar, e sim refinar o produto. Mesmo assim, cada atendimento precisa fechar no positivo. Como diria Paul Graham do YCombinator, “Do things that don’t scale”. Clínicas pequenas, que pagariam por consulta acompanhada, podem ser um canal secundário interessante mais à frente, mas não precisamos construir isso para o lançamento: o foco é o app no estilo Uber.

B2C: Acho que inicialmente, apenas pagamentos por atendimentos pontuais, como a Uber, quando entendermos a frequência média de ida dos usuários recorrentes, podemos criar um plano recorrente, como um plano de saúde, desenhado com base nesses dados de frequência: a gente toma um pouco de prejuízo nos usuários mais frequentes, mas ainda lucra na média. Isso é só para o futuro, depois de validar o primeiro ponto. Sobre Pacote mensal, eu acho que inicialmente pode confundir, como é uma solução nova, ainda é necessário educar o cliente, então deixar apenas o pagamento por atendimento pontual facilita nesse ponto. Com isso, a gente vai validar e refinar a precificação e depois, podemos explorar as outras possibilidades de cobrança. Eu tb descartaria PMPM por enquanto.

Regras de pacote já propostas

- Créditos não usados expiram e são zerados na renovação mensal; não acumulam.
- Atendimentos acima da quantidade incluída são cobrados à parte, por atendimento extra.
- Ainda deve ser confirmado se essas duas regras serão iguais nos pacotes B2B e B2C.
- A equipe deve analisar o que acontece se o crédito não for usado porque a plataforma não conseguiu disponibilizar um profissional.

Comentário do Matheus

Com o que eu disse no ponto anterior (apenas pagamento por atendimento pontual no início), já mata a necessidade de criar regras de pacotes.

Como o preço ao pagador seria formado

A proposta atual é que o profissional indique o valor-base de seu acompanhamento, um moderador aprove esse valor e a plataforma acrescente sua margem antes de cobrar o pagador, seja ele B2B ou B2C.

Para analisar a economia do modelo, a equipe deve separar:

- valor total cobrado do pagador;
- repasse ao profissional;
- taxa ou margem da plataforma;
- custos diretos de cada atendimento, como deslocamento, processamento do pagamento, coordenação e suporte.

O valor-base do profissional, o formato da margem (valor fixo ou percentual) e os critérios de aprovação pelo moderador ainda não foram definidos. Esses critérios precisam ser claros para a equipe, os profissionais e os pagadores. Uma variação muito grande entre preços de profissionais também pode dificultar contratos B2B previsíveis.

Comentário do Matheus

Como o preço é definido: Eu to de acordo com o profissional dar seu valor, mas em forma de faixa (mínimo e máximo). A plataforma escolhe o valor dentro dessa faixa com base na rota que será feita, já que o deslocamento faz parte do custo do profissional, e coloca a taxa por cima. Ex: o profissional informa R$180 a R$220; pela rota, a plataforma define R$200. Assim o fluxo fica simples: o profissional sabe que vai cobrir seus custos e ter lucro, e o usuário sabe desde o início quanto vai pagar.

Taxa da plataforma: sempre um percentual em cima do valor do profissional. *Os números a seguir são só um exemplo de como penso o modelo, não a proposta de percentual.* Se a taxa for 20% e o profissional cobrar R$200, o usuário paga R$240: R$200 vão para o profissional e R$40 para a plataforma. Note que R$40 são 20% do valor do profissional, mas 16,7% do total pago pelo usuário. O percentual faz mais sentido que um valor fixo porque, quanto mais dinheiro movimenta na plataforma, maior o nosso risco, então a taxa acompanha o volume. Antes de fixar o percentual, precisamos entender a parte fiscal e os outros custos.

Fiscal: se a plataforma faturar os R$240 inteiros como receita, o imposto incide sobre tudo; se faturar só a taxa (modelo marketplace, com split payment), incide só sobre os R$40. Minha preferência é o split payment, mas isso muda o percentual viável e precisa ser confirmado.

Tempo de espera: consultas atrasam, às vezes por horas, ainda mais no SUS. Por isso o preço inclui um número de horas, e o profissional cobra um valor fixo por hora adicional. Ex: a partir de 2h, R$50 por hora extra. Tanto as horas incluídas quanto o valor da hora adicional são definidos pelo profissional, e o usuário vê isso antes de agendar.

Cancelamento: se o cancelamento acontecer depois que o profissional já se deslocou, cobra-se uma taxa fixa de cancelamento. O valor é definido pelo profissional, e o usuário sabe disso antes de agendar.

Aprovação do preço: acho que podemos desburocratizar e não exigir aprovação manual do preço, porque o profissional sabe mais que nós quanto o serviço vale. Para evitar erros, uma moderação automática no sistema: se o valor fugir muito do esperado (ex.: R$10.000), o sistema pergunta "Você cobrou R$10.000 (dez mil reais), esse valor está correto?" e o profissional precisa digitar SIM ou NÃO para confirmar. Assim evitamos erros sem tirar a liberdade do profissional.

Custos extras: custos como limpeza do carro, caso o idoso urine ou vomite por exemplo, precisam ser cobrados. A gente tem que pensar em qual será o processo para isso, a fim de evitar fraudes de ambos os lados (cliente e profissional).

Decisões registradas e pontos em aberto

Registrado pela equipe:

- O PMPM será calculado por pessoas idosas elegíveis, não por todos os beneficiários do plano.
- Créditos não usados expiram no fechamento/renovação mensal.
- O uso acima do pacote será cobrado por atendimento extra.
- O profissional propõe um valor-base; um moderador aprova; a plataforma adiciona sua margem.
- A equipe quer considerar B2B e B2C.

Ainda precisa de decisão ou validação:

1. Qual será o primeiro pagador a investigar e qual segmento será priorizado para o piloto?
2. A equipe pretende operar B2B e B2C desde o começo ou manter um canal como hipótese secundária?
3. Quais pessoas contam como elegíveis no PMPM, e como a operadora informa o total a cada mês?
4. Quantos atendimentos ou horas entram em cada pacote, e qual é o preço do atendimento extra?
5. O pacote é igual para acompanhamento presencial e teleconsulta assistida?
6. O que conta como consulta efetivamente acompanhada para faturar, especialmente se houver cancelamento depois do deslocamento do profissional?
7. Quem paga o profissional e em que momento? Qual remuneração cobre deslocamento, espera, atendimento e retorno?
8. A margem da plataforma será fixa ou percentual? Que custos ela precisa cobrir?
9. Quais critérios o moderador usará para aprovar ou devolver o preço sugerido pelo profissional?
10. O que ocorre com créditos se a plataforma não conseguir disponibilizar um profissional no período contratado?
11. O resumo pós-consulta está incluído ou é um serviço separado? Quem o recebe?

Próxima etapa de validação

Até aqui, todas as formas de cobrança são hipóteses da equipe. A Quest 7 define o modo com apoio; a pesquisa de preço com clientes é sem assistência. A equipe deve fazer a conversa de preço e registrar as respostas sem assistência de IA, conforme o guia da quest. Depois, pode trazer resultados anonimizados para organizar e criticar.

Como o projeto envolve saúde e pessoas idosas, a equipe relata que o professor autorizou seguir com esse caminho. Continuem pedindo consentimento individual e seguindo as orientações do professor e do guia de consentimento para qualquer coleta de dados.